

REPETITOIRE QCM

Mathieu Nendaz et Jean-Luc Reny
Service de médecine interne générale.
Service de médecine interne et réhabilitation – 3C.
HUG. Genève

Petite info...

- Comme il y a 2 répétitoires de médecine interne ne soyez pas surpris que certaines disciplines soient plus représentées dans certains répétitoires
- Au total les répétitoires couvriront les disciplines majeures

Partie I

1. Chez un homme de 60 ans vous palpez dans la région sous-mandibulaire un nodule de la taille d'une cerise, dur, indolore et bien mobilisable. A l'anamnèse, le patient déclare avoir découvert ce nodule il y a 4 semaines en se rasant.

Quelle est l'affection la plus probable?

- | | |
|-----------|---|
| A. | une inflammation de la glande sous-maxillaire |
| B. | la maladie des griffes de chat (adénite virale) |
| C. | un carcinome du plancher de la bouche |
| D. | un abcès chronique d'un ganglion lymphatique |
| E. | la sarcoïdose (maladie de Boeck) |

Chez un homme de 60 ans vous palpez dans la région sous-mandibulaire un nodule de la taille d'une cerise, dur, indolore et bien mobilisable. A l'anamnèse, le patient déclare avoir découvert ce nodule il y a 4 semaines en se rasant.

Quelle est l'affection la plus probable?

Localisation unique
Inflammation : induré, indolore
Sarcoidose: pas cette localisation,

- | | |
|-----------|---|
| A. | une inflammation de la glande sous-maxillaire |
| B. | la maladie des griffes de chat (adénite virale) |
| C. | un carcinome du plancher de la bouche |
| D. | un abcès chronique d'un ganglion lymphatique |
| E. | la sarcoïdose (maladie de Boeck) |

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	une inflammation de la glande sous-maxillaire - vague, peu plausible car induré, indolore, durable
B.	la maladie des griffes de chat (adénite virale) - griffures absentes, localisation étrange
C.	un carcinome du plancher de la bouche - caractéristiques de l'ADP, âge patient, localisation
D.	un abcès chronique d'un ganglion lymphatique - pas de douleur, durée, ni inflammation locale
E.	la sarcoïdose (maladie de Boeck) - peu probable à cet âge, présentation atypique sur un site (localisation unique), ADP médiastinales surtout

ADP: DDX

- Infectieux
 - Localisé: lésion cutanéomuqueuse, mal. griffes du chat, tuberculose ...
 - Généralisé: Tbc, brucellose, toxoplasmose, HIV, CMV, EBV,...
- Tumoral
 - Solide
 - Lymphoprolifératif ADP + généralisée
- Maladies systémiques: sarcoidose, serum sickness, LES, Still,...
- Médicaments: phénytoïne...

- 2. Un patient âgé de 50 ans (170 cm, 87 kg) consulte son médecin à cause de douleurs très aiguës de la région du gros orteil gauche. L'acide urique sérique est de 780 mmol/l. Sa créatininémie est de 130 μ mol/l (N < 70)
- Quel est le traitement de choix chez ce patient?

A.	l'alcalinisation des urines
B.	l'allopurinol
C.	la colchicine
D.	l'indométacine
E.	la morphine

- Un patient âgé de 50 ans (170 cm, 87 kg) consulte son médecin à cause de douleurs très aiguës de la région du gros orteil gauche. L'acide urique sérique est de 780 mmol/l. Sa créatininémie est de 130 μ mol/l (N < 70)
- Quel est le traitement de choix chez ce patient?

A.	l'alcalinisation des urines
B.	l'allopurinol
C.	la colchicine
D.	l'indométacine
E.	la morphine

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

- | | |
|-----------|--|
| A. | l'alcalinisation des urines
- Ne traite pas la crise aiguë de goutte |
| B. | l'allopurinol
- n'est pas le traitement aigu de la goutte, ttt préventif |
| C. | la colchicine
- Indiquée pour le traitement aigu de la goutte si AINS contraindiqués
- Stéroïdes pourraient être utilisés si pas de contraindic. |
| D. | l'indométacine
- Contraindiqués ici car IR !! AINS |
| E. | la morphine
- Antalgique mais ne traite pas la cause (goutte) |

Goutte: traitement

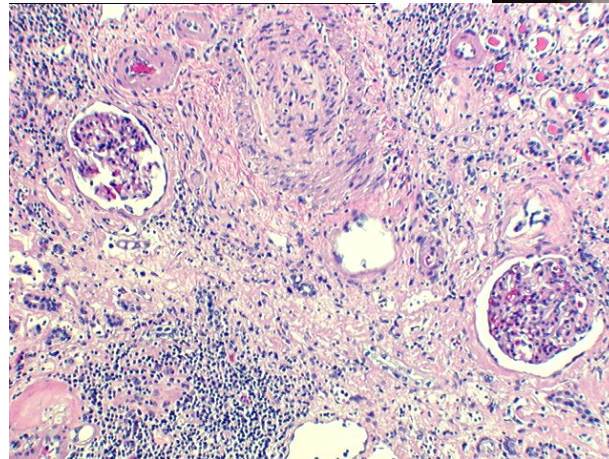
- ANTIINFLAMMATOIRE DE LA CRISE
 - AINS y.c. coxibes
 - Prednisone 30-35 mg/j x 5j
 - Colchicine: 1.5 mg puis 0.5 mg 1h plus tard, puis 0.5-2 mg/j ad résolution crise
- TRAITEMENT CHRONIQUE

but: ac urique < 360 $\mu\text{mol/l}$
introduction sous couvert antiinflammatoire, en-dehors de crise

 - Allopurinol si critères présents: de choix
 - Uricosuriques (probénécide): cave lithiase rénale

Goutte - Traitement de fond si:

- ≥ 2 crises par an
- Tophus
- Arthropathie uratique radiologique
- Néphropathie uratique



- 3. Un ouvrier de 40 ans développe un état fébrile et un exanthème maculeux partiellement hémorragique. Par la suite apparaissent une macrohématurie, un méléna et des douleurs articulaires intenses.
- Quel est le diagnostic le plus probable ?

- | | |
|-----------|--|
| A. | une périartérite noueuse |
| B. | un lupus érythémateux |
| C. | un purpura thrombopénique idiopathique |
| D. | un purpura de Schönlein-Henoch (vasculite à IgA) |
| E. | une cirrhose hépatique |

- Un ouvrier de 40 ans développe un état fébrile et un exanthème maculeux partiellement hémorragique. Par la suite apparaissent une macrohématurie, un méléna et des douleurs articulaires intenses.
- Quel est le diagnostic le plus probable ?

- | | |
|-----------|--|
| A. | une périartérite noueuse |
| B. | un lupus érythémateux |
| C. | un purpura thrombopénique idiopathique |
| D. | un purpura de Schönlein-Henoch (vasculite à IgA) |
| E. | une cirrhose hépatique |

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	une périartérite noueuse - Éruption non typique pour PAN, arthropathie et néphropathie possible
B.	un lupus érythémateux - Eruption non typique pour LES
C.	un purpura thrombopénique idiopathique - Arthralgies non typiques, éruptions typiques
D.	un purpura de Schönlein-Henoch (vasculite à IgA) - Constellation typique: éruption-arthralgies-diarrhées sanglantes-glomérulonéphrite
E.	une cirrhose hépatique - Symptômes non évocateurs

Henoch-Schönlein: (vasculite à IgA)

- Vasculite de petits vaisseaux, donc purpura
- Atteinte peau, articulations, tractus GI, reins
- Dx par biopsie cutanée: vasculite leucocytoclasique avec IgA dans la paroi des vaisseaux



Vasculites

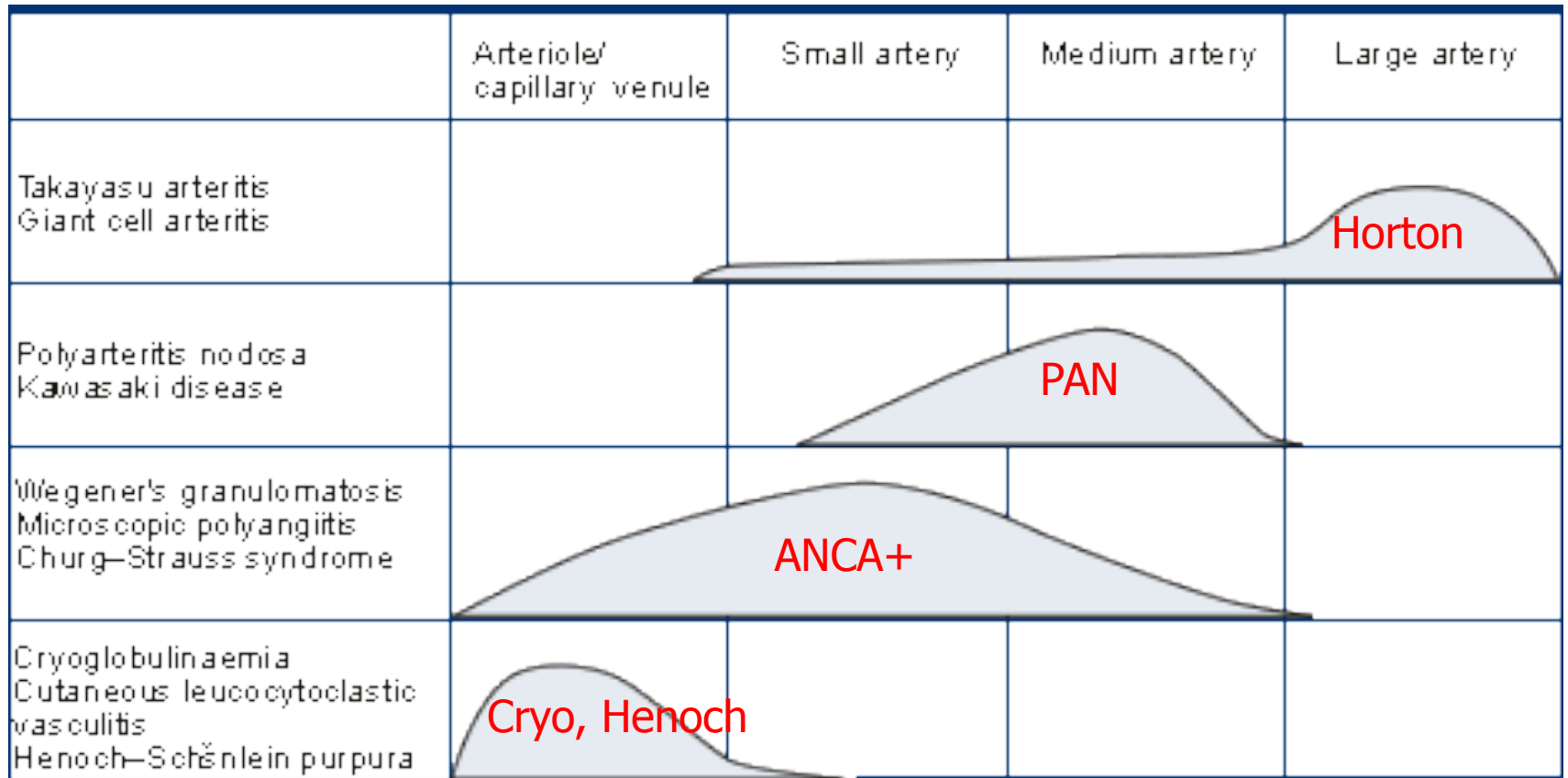
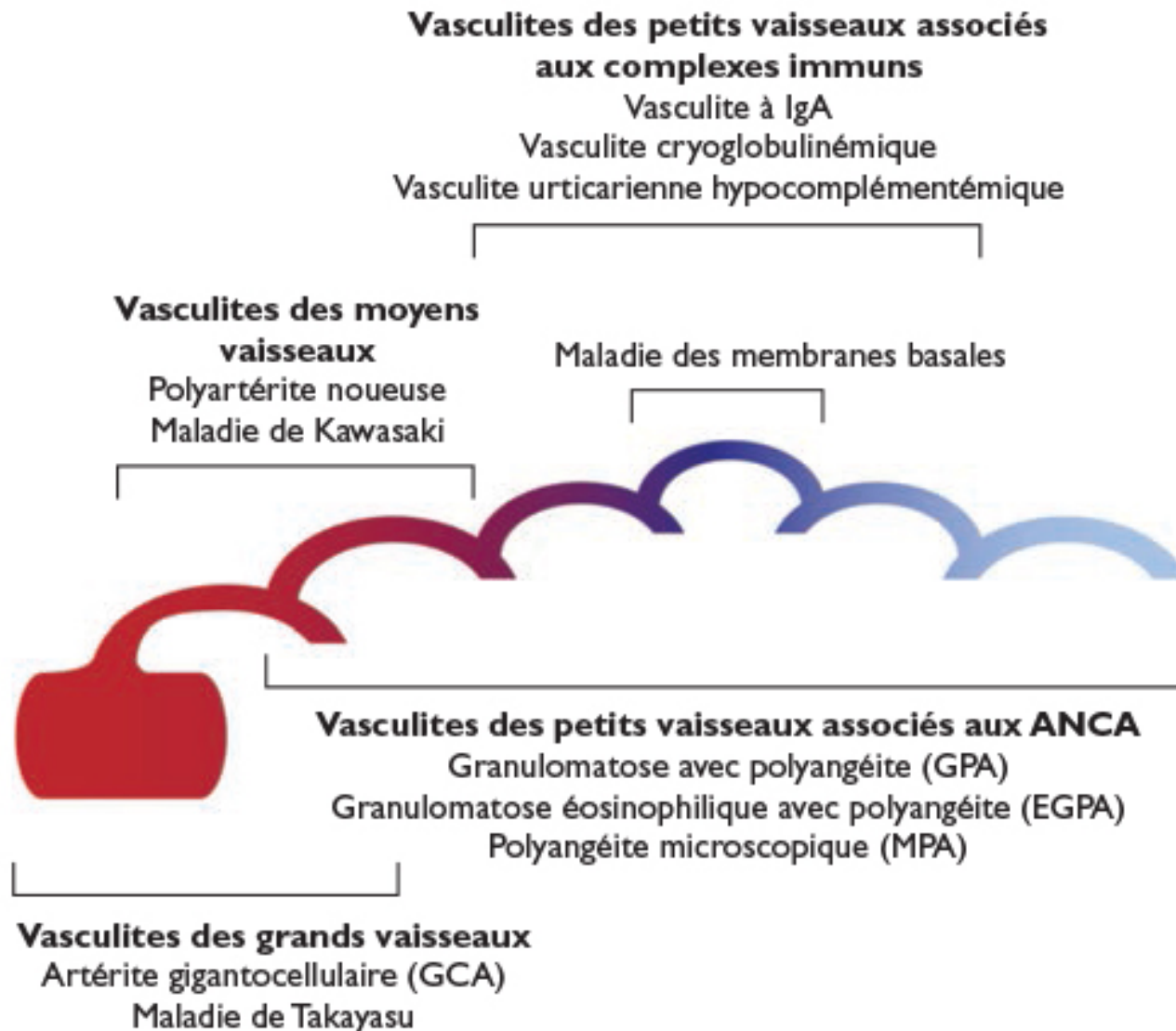


FIGURE 1. Relationship between vessel size and classification



Vasculites: clinique Σ



Claudication	Nodules cutanés	Purpura
TA asymétrique	Ulcères	Vésicules
Pas de pouls	Livedo réticulaire	Urticaire
Souffles artériels	Grangrène digitale	GN
Dilatation aortique	Mononévrite	Hémorragie alvéol.
	Episclérite	Granulomes cut
	Sclérite	Hémorr. unguéales
		Uvéite
Grand vx	Moyens vx	Petits vx

Nouvelle nomenclature

CHCC : Conférence de Consensus de Chapell Hill.

CHCC 1994	CHCC 2012
Maladie de Horton	Artérite géantocellulaire
Maladie de Churg et Strauss	Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (EGPA)
Maladie de Wegener	Granulomatose avec polyangéite (GPA)
Vasculite d'Henoch Schönlein	Vasculite à IgA

Giant cell (temporal) arteritis

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis

Granulomatosis with polyangiitis

IgA vasculitis

D Allali, C Chizzolini. Rev Med Suisse 2014;10:854-858

- 4. Une patiente de 40 ans présente depuis une année les symptômes suivants: aménorrhée, augmentation du poids de 6 kg, faiblesse des jambes, tendance aux hématomes, discrète hypertension artérielle et léger diabète sucré.
- Lequel des examens suivants a le plus de chance de contribuer au diagnostic?

A.	l'anamnèse alimentaire
B.	la détermination de la TSH plasmatique après administration de TRH
C.	la détermination de la LH et de la FSH plasmatiques après administration de GNRH (LHRH)
D.	La détermination du cortisol basal après stimulation par ACTH
E.	les 17-OH corticostéroïdes dans les urines de 24 h

- Une patiente de 40 ans présente depuis une année les symptômes suivants: aménorrhée, augmentation du poids de 6 kg, faiblesse des jambes, tendance aux hématomes, discrète hypertension artérielle et léger diabète sucré.
- Lequel des examens suivants a le plus de chance de contribuer au diagnostic? Cushing —> urines 24 h
Cortisol basal : variations importantes, pas pertinent à un moment donné

A.	l'anamnèse alimentaire
B.	la détermination de la TSH plasmatique après administration de TRH
C.	la détermination de la LH et de la FSH plasmatiques après administration de GNRH (LHRH)
D.	La détermination du cortisol basal après stimulation par ACTH Insuffisance surénalienne (Addison)
E.	les 17-OH corticostéroïdes dans les urines de 24 h

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A. l'anamnèse alimentaire
- Ne peut tout expliquer

B. la détermination de la TSH plasmatique après administration de TRH
- Hypothyroïdie plausible mais TSH seule suffit pour dépister. Hypothyroïdie hypophysaire non suspectée ici.

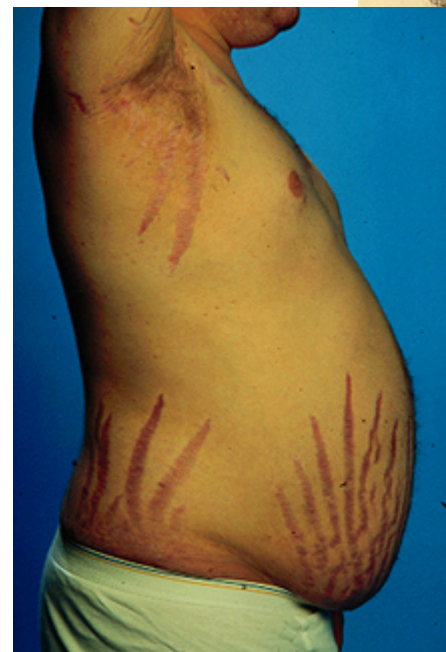
C. la détermination de la LH et de la FSH plasmatiques après administration de GNRH (LHRH)
- Insuffisance hypophysaire non suspectée ici

D. La détermination du cortisol basal après stimulation par ACTH
- Teste une insuffisance surrénalienne primaire

E. les 17-OH corticostéroïdes dans les urines de 24 h
- Syndrome de Cushing suspecté ici

Symptoms and signs of Cushing's syndrome

Symptom or sign	Reported incidence, percent
Centripetal obesity	79-97
Facial plethora	50-94
Glucose intolerance	39-90
Weakness, proximal myopathy	29-90
Hypertension	74-87
Psychological changes	31-86
Easy bruisability	23-84
Hirsutism	64-81
Oligomenorrhea or amenorrhea	55-80
Impotence	55-80
Acne, oily skin	26-80
Abdominal striae	51-71
Ankle edema	28-60
Backache, vertebral collapse, fracture	40-50
Polydipsia, polyuria	25-44
Renal calculi	15-19
Hyperpigmentation	4-16
Headache	0-47
Exophthalmos	0-33
Tinea versicolor infection	0-30
Abdominal pain	0-21



- 5. Une jeune femme de 18 ans arrive à l'hôpital avec des nausées, des vomissements, une polyurie et une polydipsie d'apparition récente.
- Un diagnostic d'acidocétose d'un diabète inaugural de type I est posé. Un traitement de soluté isotonique, d'insuline et de potassium est administré. La glycémie, qui à l'admission était de 25 mmol/l (450 mg/dl), descend progressivement et est à 4 mmol/l (72 mg/dl) 12 heures après l'admission.
- Que faut-il faire à ce stade?

A.	arrêter l'insuline
B.	arrêter l'insuline et commencer une perfusion de glucose
C.	diminuer l'insuline
D.	diminuer l'insuline et commencer une perfusion de glucose
E.	continuer le même traitement

- Une jeune femme de 18 ans arrive à l'hôpital avec des nausées, des vomissements, une polyurie et une polydipsie d'apparition récente.
- Un diagnostic d'acidocétose d'un diabète inaugural est posé. Un traitement de soluté isotonique, d'insuline et de potassium est administré. La glycémie, qui à l'admission était de 25 mmol/l (450 mg/dl), descend progressivement et est à 4 mmol/l (72 mg/dl) 12 heures après l'admission.
- Que faut-il faire à ce stade?

A.	arrêter l'insuline
B.	arrêter l'insuline et commencer une perfusion de glucose
C.	diminuer l'insuline
D.	diminuer l'insuline et commencer une perfusion de glucose
E.	continuer le même traitement

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	arrêter l'insuline - Risque de cétose!
B.	arrêter l'insuline et commencer une perfusion de glucose - Risque de cétose et d'hyperglycémie!
C.	diminuer l'insuline - Risque d'hypoglycémie tout de même vu glycémie à 4
D.	diminuer l'insuline et commencer une perfusion de glucose - Inhibition de production de corps cétoniques par insuline obligatoire à maintenir
E.	continuer le même traitement - Risque d'hypoglycémie

- 6. Un patient avec une cirrhose hépatique présente une ascite massive accompagnée de dyspnée marquée, une hyponatrémie à 125 mmol (norme 133-142) et une hypoalbuminémie à 20 g/l (norme 33-52).
- Quel est le meilleur traitement immédiat ?

A.	furosémide iv.
B.	spirololactone iv.
C.	paracentèse de plusieurs litres
D.	perfusion d'albumine
E.	correction de l'hyponatrémie par perfusion de NaCl hypertonique

- Un patient avec une cirrhose hépatique présente une ascite massive accompagnée de dyspnée marquée, une hyponatrémie à 125 mmol (norme 133-142) et une hypoalbuminémie à 20 g/l (norme 33-52).
- Quel est le meilleur traitement immédiat ?

A. furosémide iv.

B. spirololactone iv.

C. paracentèse de plusieurs litres

D. perfusion d'albumine

E. correction de l'hyponatrémie par perfusion de NaCl hypertonique

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

- | | |
|-----------|--|
| A. | furosémide iv.
- Peu efficace immédiatement, risque de syndrome hépatorénal (IR induite par les diurétiques) |
| B. | spirololactone iv.
- Peu efficace immédiatement |
| C. | paracentèse de plusieurs litres
- Sous couverture de perfusion d'albumine |
| D. | perfusion d'albumine
- Augmente la volémie |
| E. | correction de l'hyponatrémie par perfusion de NaCl hypertonique
- Risque d'hypervolémie ou aggravation ascite
- Pas indiqué dans cette situation |

- 7. Une femme de 28 ans vous consulte à cause de douleurs récidivantes des grandes et petites articulations qui sont légèrement enflées, ainsi que d'une fatigue générale. Cette symptomatologie dure depuis environ 1 année 1/2.
- Radiologiquement, les articulations sont normales.
VS: 60 mm/h, Hb: 7.8 g/dl (N > 11)
- Quel est le diagnostic le plus probable?

A. Lupus érythémateux disséminé

B. Syndrome de Reiter

C. Chondrocalcinose

D. Polymyalgia rheumatica

E. Goutte

- Une femme de 28 ans vous consulte à cause de douleurs récidivantes des grandes et petites articulations qui sont légèrement enflées, ainsi que d'une fatigue générale. Cette symptomatologie dure depuis environ 1 année 1/2.
- Radiologiquement, les articulations sont normales.
VS: 60 mm/h, Hb: 7.8 g/dl (N > 11)
- Quel est le diagnostic le plus probable?

A.	Lupus érythémateux disséminé
B.	Syndrome de Reiter
C.	Chondrocalcinose
D.	Polymyalgia rheumatica
E.	Goutte

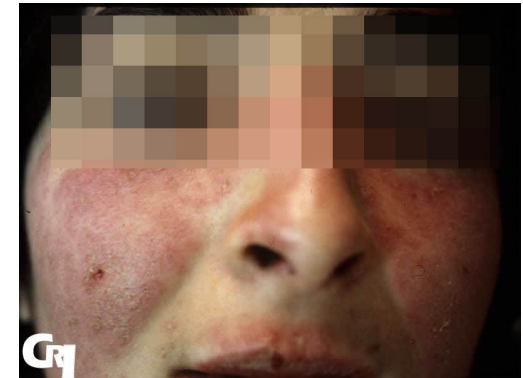
Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	Lupus érythémateux disséminé - femme, symptômes chroniques
B.	Syndrome de Reiter - Fait partie des spondylarthrites réactionnelles - Arthrite, conjonctivite, uréthrite
C.	Chondrocalcinose - Dépôt de cristaux de pyrophosphate dans les articulations, touche personnes plus âgées ou souffrant d'hémochromatose
D.	Polymyalgia rheumatica - Racine des membres douloureuses et faibles - Patients > 50ans
E.	Goutte - Arthrite aiguë mono (oligo)-articulaire

Frequency of symptoms of systemic lupus erythematosus

Symptoms	Percent at onset	Percent at anytime
Fatigue	50	74-100
Fever	36	40-80+
Weight loss	21	44-60+
Arthritis or arthralgia	62-67	83-95
Skin	73	80-91
Butterfly rash	28-38	48-54
Photosensitivity	29	41-60
Mucuous membrane lesion	10-21	27-52
Alopecia	32	18-71
Raynaud's phenomenon	17-33	22-71
Purpura	10	15-34
Uticaria	1	4-8
Renal	16-38	34-73
Nephrosis	5	11-18
Gastrointestinal	18	38-44
Pulmonary	2-12	24-98
Pleurisy	17	30-45
Effusion		24
Pneumonia		29
Cardiac	15	20-46
Pericarditis	8	8-48
Murmurs		23
ECG changes		34-70
Lymphadenopathy	7-16	21-50
Splenomegaly	5	9-20
Hepatomegaly	2	7-25
Central nervous system	12-21	25-75
Functional		Most
Psychosis	1	5-52
Convulsions	0.5	2-20

Adapted from: Von Feldt, JM, Postgrad Med 1995; 97:79.



Lupus cutané aigu



Lupus cutané subaigu

Anti-DNA-ds
Sensibilité 70% Spécificité 95%

Les associations classiques...

	Anticorps anti-
Lupus érythémateux systémique (LES)	DNA-ds , Sm (spécifiques) Ro (=SSA), La (=SSB)
Lupus médicamenteux	Histone (peu spécifiques)
Lupus cutané subaigu	Ro (=SSA), La (=SSB)
Sjögren	Ro (=SSA) La (=SSB)
Sclérodermie	Topoisomérase-3 (Scl-70) Centromère
Polymyosite	RNA-synthétase (Jo-1,...) SRP (signal recognition particle in RE)
MCTD (Sharp)	U1-RNP (requis pour le diagnostic)

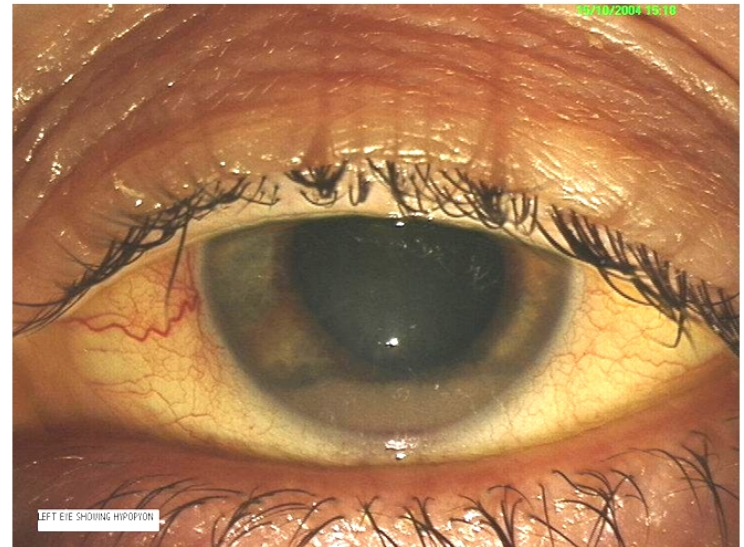
Spondylarthrite réactionnelle (réactive)

- **Spondylarthrite** réactionnelle

- Enthésites (inflammation insertion des ligaments et tendons dans l'os)
- Arthrite – conjonctivite – urétrite (Reiter)
 - triade présente dans moins de 33%
- Parfois uvéite (HLA-B27 +)
- Post infections : GI ou uro-génital
 - Salm, Shig, Yersin, Campylobact,
 - Chlamyd, mycopl-ureaplasma

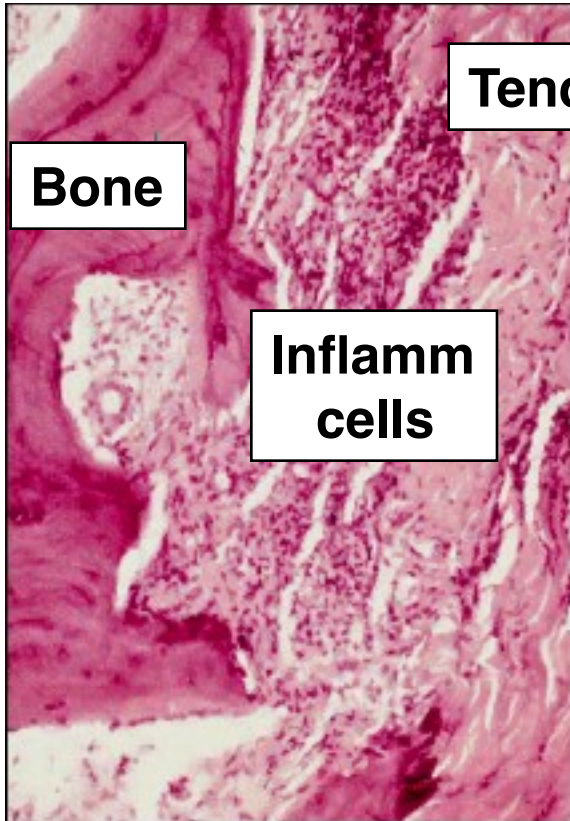
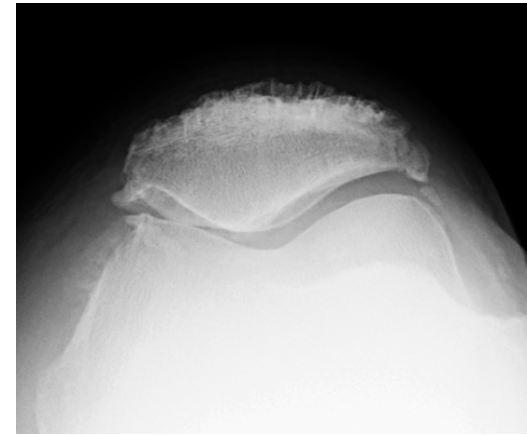


Conjonctivite



Uvéite

Enthésites



Tendon

Bone

**Inflamm
cells**



« colonne bambou »

Enthésite

Spondylarthrites, nouvelle classif.

- Spondylarthrite ankylosante
- Spondylarthrites psoriasiques
- Spondylarthrites associées aux MICIs
- Spondylarthrites réactives
- Spondylarthrites indifférenciées



■ Prédominance axiale



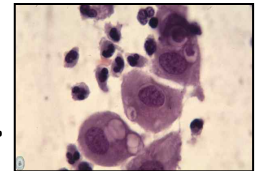
■ Prédominance périphérique



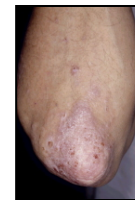
■ Axiale-périphérique

+/-

■ Infection UG ou intest.



■ Psoriasis



■ Atteinte intestinale inflamm.



- 8. Un alcoolique chronique atteint d'une cirrhose micronodulaire, développe sur 3 mois des douleurs abdominales. On constate un gros foie douloureux et dur, ainsi que de la fièvre.
- Quelle est la cause la plus probable de la détérioration de son état?

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| A. | une hépatite éthylique aiguë |
| B. | une cholangite aiguë |
| C. | une hépatite virale aiguë |
| D. | un carcinome hépatocellulaire |
| E. | un abcès hépatique |

- Un alcoolique chronique atteint d'une cirrhose micronodulaire, développe progressivement des douleurs abdominales. On constate un gros foie douloureux et dur, ainsi que de la fièvre.
- Quelle est la cause la plus probable de la détérioration de son état?

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| A. | une hépatite éthylique aiguë |
| B. | une cholangite aiguë |
| C. | une hépatite virale aiguë |
| D. | un carcinome hépatocellulaire |
| E. | un abcès hépatique |

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	une hépatite éthylique aiguë - Chronologie, douleur pas typique
B.	une cholangite aiguë - Foie gros et dur contre
C.	une hépatite virale aiguë - chronologie
D.	un carcinome hépatocellulaire induration ! -Complication classique -Dx: imagerie, dosage AFP
E.	un abcès hépatique masse palpable - Foie gros et dur contre

- Un homme de 63 ans est admis aux urgences à cause de douleurs dans l'hypochondre droit. Il est dans un état général diminué, sa température est de 38.3° C. A la palpation, il présente une douleur de l'hypochondre droit sans défense, ainsi qu'un ictère.
- Laboratoire:
 - bilirubine 83 mmol/l (norme 2-18)
 - ALAT 120 U/l (norme 5-20)
 - phosphatase alcaline 320 U/l (norme 20-200)
 - leucocytes $14 \times 10^9/l$, neutrophiles 85 %
- L'échographie montre une lithiase vésiculaire, ainsi qu'une dilatation des voies biliaires intra-et extrahépatiques.
- Quelle est la démarche correcte dans cette situation?

A.	antibiothérapie seule
B.	antibiothérapie et cholécystectomie d'urgence
C.	antibiothérapie, ERCP avec papillotomie, cholécystectomie laparoscopique ultérieure
D.	antibiothérapie, drainage endoscopique ou transhépatique sans cholécystectomie
E.	une tomographie computerisée abdominale

- Un homme de 63 ans est admis aux urgences à cause de douleurs dans l'hypochondre droit. Il est dans un état général diminué, sa température est de 38.3° C. A la palpation, il présente une douleur de l'hypochondre droit sans défense, ainsi qu'un ictère.
- Laboratoire:
 - bilirubine 83 mmol/l (norme 2-18)
 - ALAT 120 U/l (norme 5-20)
 - phosphatase alcaline 320 U/l (norme 20-200)
 - leucocytes 14x10⁹/l neutrophiles 85 %
- L'échographie montre une lithiase vésiculaire, ainsi qu'une dilatation des voies biliaires intra-et extrahépatiques.
- Quelle est la démarche la plus correcte dans cette situation?

A.	antibiothérapie seule
B.	antibiothérapie et cholécystectomie d'urgence
C.	antibiothérapie, ERCP avec papillotomie, cholécystectomie laparoscopique ultérieure
D.	antibiothérapie, drainage endoscopique ou transhépatique sans cholécystectomie
E.	une tomographie computerisée abdominale

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

- Cholangite avec calcul enclavé
 - → traitement aigu = enlever le calcul et traiter l'infection
 - → traitement « à froid », une fois l'infection traitée : enlever la source de calculs: cholécystectomie

A.	antibiothérapie seule
B.	antibiothérapie et cholécystectomie d'urgence
C.	antibiothérapie, ERCP avec papillotomie, cholécystectomie laparoscopique ultérieure
D.	antibiothérapie, drainage endoscopique ou transhépatique sans cholécystectomie
E.	une tomographie computerisée abdominale - Échographie très sensible pour VB

- Un homme de 64 ans est hospitalisé avec une fracture de la jambe gauche. Il est parfaitement orienté dans le temps et dans l'espace. A part la blessure, l'examen physique est sans particularité.
- Laboratoire :
 - Hémoglobine 13.2 g/dl (N: 13.5-18), MCV 112 (N 80-100), leucocytes 6'000 G/l (N: 4'000-11'000)
 - ASAT, ALAT normales
 - gamma-GT 3 fois la norme
- La fracture est traitée chirurgicalement.
- Trois jours plus tard, il est désorienté, commence à trembler et à halluciner. La numération leucocytaire est maintenant à 12'000 G/l et sa température corporelle monte à 38.6° C.
- Quel est le traitement le plus approprié?

A. lorazepam

B. propranolol

C. halopéridol

D. imipramine

E. phénobarbital

- Un homme de 64 ans est hospitalisé avec une fracture de la jambe gauche. Il est parfaitement orienté dans le temps et dans l'espace. A part la blessure, l'examen physique est sans particularité.
- Laboratoire :
 - Hémoglobine 13.2 g/dl (N: 13.5-18), MCV 112 (N 80-100), leucocytes 6'000 G/l (N: 4'000-11'000)
 - ASAT, ALAT normales
 - gamma-GT 3 fois la norme
- La fracture est traitée chirurgicalement.
- Trois jours plus tard, il est désorienté, commence à trembler et à halluciner. La numération leucocytaire est maintenant à 12'000 G/l et sa température corporelle monte à 38.6° C.
- Quel est le traitement le plus approprié?

A.	lorazepam
B.	propanolol
C.	halopéridol
D.	imipramine
E.	phénobarbital

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

- DX: syndrome de sevrage éthylique
 - Agitation, tremor, hallucinations, EF
 - Peut se manifester plusieurs jours après arrêt d'OH

A.	lorazepam -Ou oxazepam -Ne pas oublier vit B1 (thiamine)
B.	propanolol - Prévention II de saignements de varices oesophagiennes
C.	halopéridol - Pas indiqué en premier choix
D.	Imipramine - ADT pas indiqué
E.	phénobarbital - Barbiturique pas indiqué

- Un chef comptable âgé de 58 ans est hospitalisé à cause d'une faiblesse générale. Dans son anamnèse, on relève une tuberculose pulmonaire il y a 15 ans.
L'examen clinique est normal à l'exception d'une contracture de Dupuytren à la main gauche.
- Laboratoire :
 - sodium 132 mmol/l , potassium 5.9 mmol/l , créatinine 82 umol/l
 - hémoglobine 11.2 g/dl (N>12)
 - leucocytes 4.9 G/l avec 9 % d'éosinophiles (norme: 1-4 %)
 - thrombocytes 158 G/l
- Quel examen confirmera votre diagnostic de suspicion?

A.	un test de stimulation à l'ACTH
B.	la mesure du Na et K dans les urines de 24 h
C.	une ponction de la moelle osseuse
D.	un examen des expectorations à la recherche de mycobactéries
E.	la mesure de l'albumine, du quick et du facteur V

- Un chef comptable âgé de 58 ans est hospitalisé à cause d'une faiblesse générale. Dans son anamnèse, on relève une tuberculose pulmonaire il y a 15 ans.
L'examen clinique est normal à l'exception d'une contracture de Dupuytren à la main gauche.
- Laboratoire :
 - sodium 132 mmol/l , potassium 5.9 mmol/l , créatinine 82 umol/l
 - hémoglobine 11.2 g/dl (N>12)
 - leucocytes 4.9 G/l avec 9 % d'éosinophiles (norme: 1-4 %)
 - thrombocytes 158 G/l
- Quel examen confirmera votre diagnostic de suspicion?

A.	un test de stimulation à l'ACTH
B.	la mesure du Na et K dans les urines de 24 h
C.	une ponction de la moelle osseuse
D.	un examen des expectorations à la recherche de mycobactéries
E.	la mesure de l'albumine, du quick et du facteur V

Diagnostic ?

- Fatigue
 - Hyponatrémie – hyperkaliémie
 - Éosinophilie
 - Contexte tuberculose
-
- Parlent pour maladie d'Addison (insuffisance surrénalienne)

Causes of adrenal insufficiency (Addison's disease)

Autoimmune adrenalitis
Isolated adrenal insufficiency
Polyglandular autoimmune syndrome type I
Polyglandular autoimmune syndrome type II
Infectious adrenalitis
Tuberculosis
Disseminated fungal infection
Histoplasmosis
Paracoccidioidomycosis
HIV infection and AIDS
Syphilis
African trypanosomiasis
Metastatic cancer
Primarily lung, breast, stomach and colon cancer or lymphoma
Adrenal hemorrhage or infarction
Drugs
Ketoconazole
Rifampin
Phenytoin
Barbiturates
Megestrol acetate
Other- aminoglutethimide, etomidate, metyrapone, suramin, mitotane
Other
Adrenoleukodystrophy and adrenomyeloneuropathy
Congenital adrenal hypoplasia
Familial glucocorticoid deficiency
Familial glucocorticoid resistance
Defective cholesterol metabolism

Comparison of representative corticosteroid preparations

	Approximate equivalent dose*, mg	Relative anti-inflammatory activity	Relative mineralocorticoid activity	Duration of action, hours
Cortisol•	20	1	1	8-12
Cortisone acetate	25	0.8	0.8	8-12
Hydrocortisone	20	1	1	8-12
Prednisone	5	4	0.8	12-36
Prednisolone	5	4	0.8	12-36
Methylprednisolone	4	5	0.5	12-36
Triamcinolone	4	5	0	12-36
Fludrocortisone	Δ	10	125	12-36
Dexamethasone	0.75	30	0	36-72

* Equivalent dose shown is for oral or IV administration. Relative potency for intra-articular or intramuscular administration may vary considerably.

• Data for cortisol, endogenous corticosteroid hormone, are included for comparison with synthetic preparations listed.

Δ Fludrocortisone is not used for an anti-inflammatory effect.

Data from: Schimmer, BP, Parker, KL; *Adrenocorticotrophic hormone; adrenocortical steroids and their synthetic analogs; inhibitors of the synthesis and actions of adrenocortical hormones*; Chap 59

Pharmacological basis of therapeutics; 11th ed Brunton, LL et al eds. 2006 McGraw Hill, New York, NY.

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	un test de stimulation à l'ACTH - Cortisol basal et test de stimulation: pour insuffisance surrénalienne primaire
B.	la mesure du Na et K dans les urines de 24 h - Utile pour augmenter suspicion mais pas diagnostique (on s'attend à u-Na élevé et u-K bas)
C.	une ponction de la moelle osseuse - Le problème n'est pas hématologique
D.	un examen des expectorations à la recherche de mycobactéries - Certainement peu rentable: examen des surrénales plus utile
E.	la mesure de l'albumine, du quick et du facteur V - Pas de rapport

- Chez un homme de 72 ans, on découvre une anémie ferriprive avec du sang occulte dans les selles.
A l'anamnèse, il n'y a aucune notion de méléna ou d'hématémèse.
Le malade ne se plaint pas de douleurs abdominales, ni d'une modification de ses habitudes de défécation.
- Quelle est la source d'hémorragie la plus probable?

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| A. | un carcinome œsophagien |
| B. | un ulcère duodéal |
| C. | un carcinome du côlon ascendant |
| D. | un carcinome du rectum |
| E. | des hémorroïdes internes |

- Chez un homme de 72 ans, on découvre une anémie ferriprive avec du sang occulte dans les selles.
A l'anamnèse, il n'y a aucune notion de méléna ou d'hématémèse.
Le malade ne se plaint pas de douleurs abdominales, ni d'une modification de ses habitudes de défécation.
- Quelle est la source d'hémorragie la plus probable?

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| A. | un carcinome œsophagien |
| B. | un ulcère duodéal |
| C. | un carcinome du côlon ascendant |
| D. | un carcinome du rectum |
| E. | des hémorroïdes internes |

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	un carcinome œsophagien - plausible, mais pas de dysphagie, et prévalence moindre sans FR
B.	un ulcère duodénal - plausible, mais cf épidémiologie cancer
C.	un carcinome du côlon ascendant - À exclure en premier dans cette classe d'âge
D.	un carcinome du rectum - Sang frais plutôt
E.	des hémorroïdes internes -Sang frais plutôt -Même si hémorroïdes présentes, cancer à exclure

- Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses (voir figure). Auparavant, le patient a présenté un exanthème passager également non prurigineux. Qu'est-ce qui est indiqué en premier lieu?



- | | |
|-----------|---|
| A. | un traitement d'épreuve de courte durée avec une crème à la cortisone |
| B. | une culture mycologique |
| C. | un examen histologique |
| D. | un examen sérologique |
| E. | des tests épicutanés |

Le diagnostic...



Rash maculaire
(spots)
Vésicules de divers
âges ???



Syndrome pied-main-bouche (Coxsackie A):
vésicules (Uptodate)



Syphilis II: pigmenté et
maculaire (Uptodate)



Erythème multiforme:
HSV, mycoplasme, autres
inconnus (Uptodate)



Primo-infection HIV:
maculo-papuleux
(RevMedSuisse)

- Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses (voir figure). Auparavant, le patient a présenté un exanthème passager également non prurigineux. Qu'est-ce qui est indiqué en premier lieu?



- | | |
|-----------|---|
| A. | un traitement d'épreuve de courte durée avec une crème à la cortisone |
| B. | une culture mycologique |
| C. | un examen histologique |
| D. | un examen sérologique |
| E. | des tests épicutanés |

Pourquoi c'est faux - pourquoi c'est juste

A.	un traitement d'épreuve de courte durée avec une crème à la cortisone - Diagnostic avant stéroïdes!
B.	une culture mycologique - Pas d'aspect d'infection mycotique
C.	un examen histologique - Serait indiqué pour érythème multiforme
D.	un examen sérologique - Le plus rentable vu le ddx
E.	des tests épicutanés - Si allergie suspecte, mais ici, pas typique d'eczéma, pas de prurit

Enteroviruses

- Poliomyélite
 - Atteinte neurologique
- Non-polyomyélite: Coxsackie- A et B, echo-, enterovirus
 - Syndrome fébrile
 - Atteinte cutanée: rash non spécifique, syndrome pied-main-bouche (coxsackie)
 - Pleurite (Bornholm!)
 - Myopéricardite
 - Méningite

Primo-infection HIV

Tableau 1. Symptômes et signes cliniques rencontrés pendant la primo-infection VIH

Symptôme	%
Fièvre	~ 75%
Asthénie	~ 70%
Rash	~ 50%
Myalgies	~ 50%
Céphalées	~ 50%
Pharyngite	~ 40%
Adénopathies	~ 40%
Arthralgies	~ 30%
Nausées-diarrhées	~ 25%
Sueurs nocturnes	~ 25%
Ulcères buccaux et génitaux	~ 15%
Candidose buccale et/ou œsophagienne	~ 10%
Méningite	~ 10%

Syphilis

- Incubation: 21j (3-90)
- I: Chancre + ADP locale
 - Indolore
 - Guérison spontanée en 2-3 sem.
- II: semaines à mois plus tard
 - Syndrome fébrile systémique pseudo-grippal
 - Rash
 - Méningite, uvéite
 - Hépatite, entérite, glomérulonéphrite
- III: années plus tard
 - Neurosyphilis:
 - Tabes dorsal: atteinte des cordons postérieurs
 - Démentification
 - Gommès syphilitiques (granulomes) sur divers organes
 - Blocs de conduction cardiaque, insuffisance aortique



Lésions cutanées diffuses

- Infections
 - Ne pas oublier rougeole, rubéole
 - HIV, parvovirus B19, CMV, EBV, enteroviruses, syphilis, etc.
 - Fièvre rhumatoïde
- Allergies
 - Médicaments notamment !
- Maladies immunologiques
 - Vasculite à IgA (Schonlein-Henoch)
 - LES
 - Cryoglobulinémies
 - Etc.
- Maladies dermatologiques pures